VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2026
tom 11, e05326004
Copyright © 2026 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.110437

Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dotyczące szczepienia przeciw RSV (RSVpreF) kobiet w ciąży

Position Statement of the Experts of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians, the Polish Society of Family Medicine, and the Polish Society of Vaccinology on RSV vaccination (RSVpreF) in pregnant women

Aneta Nitsch-Osuch[1], Ernest Kuchar[2], Agnieszka Mastalerz-Migas[3], Piotr Sieroszewski[4], Mirosław Wielgoś[5], Jacek Wysocki[6]

[1]Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
[2]Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
[3]Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[4]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[5]Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
[6]Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

1. Szczepionka przeciw RSV (RSVpreF) rekomendowana jest do podawania w 32.–36. tygodniu ciąży w celu ochrony przed ciężkim zakażeniem RSV niemowląt do 6. miesiąca życia.
2. Szczepionka przeciw RSV (RSVpreF) może być podana po ukończeniu 24. tygodnia ciąży, co jest zgodne z zapisem w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL). Jej zastosowanie powinno być rozważone, gdy występują wskazania położnicze (np. zagrożenie porodem przedwczesnym).
3. Szczepionka przeciw RSV (RSVpreF) podawana kobietom w ciąży jest skuteczna w zapobieganiu ciężkim zakażeniom RSV u niemowlęcia.
4. Szczepionka przeciw RSV (RSVpreF) podawana w ciąży jest bezpieczna dla matki i dziecka.

ETIOLOGIA I EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻEŃ RSV

Nazwa syncytialnego wirusa oddechowego (RSV, *respiratory syncytial virus*), wywołującego zakażenia dróg oddechowych, pochodzi od specyficznego namnażania się wirusa w komórkach układu oddechowego: zakażone komórki zlewają się ze sobą w duże struktury, tworząc tak zwane syncytia [1].

Zakażenie szerzy się drogą kropelkową lub kontaktową. Zakaźność RSV jest duża, szacuje się, że jeden zakażony może zakazić średnio 3–4 osoby z otoczenia.

Adres do korespondencji: Aneta Nitsch-Osuch, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wojciecha Oczki 3, 02–007 Warszawa, e-mail: anitsch@wum.edu.pl

Otrzymano: 29.12.2025 **Zaakceptowano:** 29.12.2025 **Opublikowano:** 13.02.2026

Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 8 dni (średnio 4–6 dni). Przebycie zakażenia RSV nie daje trwałej odporności, dlatego można chorować wielokrotnie, choć kolejne zakażenia mają zwykle łagodniejszy przebieg. Zakażenie występuje w każdym wieku, ale najcięższy przebieg obserwowany jest u dzieci do 1.–2. roku życia oraz u osób starszych (po 65. roku życia). Zakażenia wywołane przez RSV mają charakter sezonowy, na półkuli północnej pojawiają się zwykle od października do końca stycznia/lutego. Pandemia COVID-19 zaburzyła tę sezonowość (zakażenia RSV występowały wcześniej), ale obecnie obserwowany jest powrót do wcześniejszego wzorca najwyższej zapadalności [1].

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, W*orld Health Organization*) szacuje, że RSV jest odpowiedzialny za 63% ostrych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Najczęstsze objawy zakażenia — kaszel, katar oraz gorączka — mogą mieć charakter samoograniczający się, ale u najmłodszych dzieci istnieje wysokie ryzyko wystąpienia zapalenia oskrzelików. Możliwe są powikłania krótkoterminowe (zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego) oraz długoterminowe (nawracające epizody świszczącego oddechu, a także zaostrzenie astmy oskrzelowej) [1]. Nie ma leczenia przyczynowego zakażenia RSV. Praktycznie wszystkie dzieci do 2. roku życia przynajmniej raz są zakażone tym wirusem [2]. Szacuje się, że 20% dzieci do 2. roku życia w przebiegu zakażenia RSV wymaga pomocy ambulatoryjnej, a 1 na 50 niemowląt — hospitalizacji, przy czym 79% hospitalizacji dotyczy dzieci pierwotnie zdrowych, nieobciążonych wcześniactwem czy chorobami przewlekłymi [3–5].

Raportowanie przypadków RSV w Polsce rozpoczęto dopiero w lutym 2023 roku, a z danych zawartych w meldunkach epidemiologicznych tworzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH — Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH–PIB) — wynika, że około połowa zachorowań dotyczy dzieci do 2. roku życia [6, 7]. Szacuje się także, że liczba hospitalizacji z powodu zakażeń RSV w Polsce wynosi 267,5/100 000 dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz 1132,1/100 000 dzieci poniżej 1. roku życia [7].

DLACZEGO REKOMENDOWANE JEST SZCZEPIENIE KOBIET W CIĄŻY PRZECIW RSV?

Ze względu na częste występowanie, możliwość wielokrotnych zachorowań, wysokie ryzyko hospitalizacji w pierwszych miesiącach życia i nieprzewidywalny przebieg choroby u danego dziecka, a także brak leczenia przyczynowego, działania profilaktyczne powinny dotyczyć każdego dziecka (a nie tylko grup ryzyka, np. dzieci przedwcześnie urodzonych).

Obecnie dostępne są trzy formy profilaktyki zakażeń RSV u dzieci:

- szczepienia kobiet w ciąży,
- stosowanie u dzieci po urodzeniu przeciwciała monoklonalnego: paliwizumabu (dostępnego w Polsce w grupach ryzyka, podawanego w ramach programu lekowego w postaci comiesięcznych iniekcji domięśniowych wykonywanych od września do końca marca);
- stosowanie u dzieci po urodzeniu przeciwciała monoklonalnego: nirsewimabu (stan na 12.2025 r. — dostępny w Polsce) lub klesrowimabu (stan na 12.2025 r. — niedostępny w Polsce); przeciwciała monoklonalnego o przedłużonym okresie półtrwania, podawanego jednorazowo domięśniowo i zapewniającego ochronę przed zachorowaniem przez 6 miesięcy [7–10].

Szczepionki przeciw RSV

Obecnie w Polsce zarejestrowane są dwie szczepionki przeciw RSV (ale tylko jedna z nich może być podana kobietom w ciąży) [11, 12]:

- RSVPreF3 OA — szczepionka podjednostkowa rekombinowana, zawierająca glikoproteinę F RSV w konformacji przedfuzyjnej oraz adiuwant AS01E — przeznaczona do profilaktyki zakażeń RSV u dorosłych w wieku powyżej 60 lat oraz u dorosłych z grup ryzyka w wieku 50–59 lat;
- RSVpreF — szczepionka podjednostkowa rekombinowana, zawierająca glikoproteinę F podtypu A i B RSV w konformacji przedfuzyjnej — przeznaczona do profilaktyki zakażeń RSV u dorosłych w wieku powyżej 18 lat oraz u kobiet w ciąży.

Szczepionka przeciw RSV stosowana u kobiet w ciąży — rekomendacje na świecie i w Polsce

Szczepionka RSVpreF przeznaczona jest do stosowania u kobiet w ciąży w celu ochrony przed ciężkim zakażeniem RSV niemowląt do 6. miesiąca życia. Jest to szczepionka należąca do kategorii tak zwanych szczepionek nieżywych, które nie zawierają zdolnych do replikacji w organizmie człowieka wirusów. Głównym składnikiem szczepionki jest antygen w postaci białka F w konformacji przedfuzyjnej (czyli tej występującej na zakaźnych cząstkach wirusowych przed ich związaniem się z receptorem na komórce gospodarza), uzyskanego metodą rekombinacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA, *deoxyribonucleic acid*) [11].

Komisja Europejska 24 sierpnia 2023 roku zatwierdziła szczepionkę RSVpreF do stosowania u kobiet w ciąży w celu ochrony niemowląt przed zakażeniem dolnych dróg oddechowych o etiologii RSV w pierwszych

Tabela 1. Zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko RSV kobiet w ciąży w różnych krajach [14, 16–21]

Kraj	Rekomendacja
Austria	1 dawka szczepionki podana między 24. a 36. tygodniem ciąży, krótko przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego RSV
Wielka Brytania	1 dawka szczepionki podana między 28. a 36. tygodniem ciąży, krótko przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego RSV
Belgia	1 dawka szczepionki podana między 28. a 36. tygodniem ciąży, krótko przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego RSV
Francja	1 dawka szczepionki podana między 32. a 36. tygodniem ciąży, krótko przed rozpoczęciem sezonu epidemicznego RSV
Argentyna	1 dawka szczepionki podana między 32. a 36. tygodniem ciąży, w trakcie trwania sezonu epidemicznego RSV
Stany Zjednoczone	1 dawka szczepionki między 32. a 36. tygodniem ciąży, podawana sezonowo (wrzesień–styczeń w większości stanów) w celu zapobiegania zakażeniom dolnych dróg oddechowych związanym z RSV u niemowląt w wieku < 6 miesięcy

RSV (*respiratory syncytial virus*) — syncytialny wirus oddechowy

6 miesiącach życia, wskazując, że pojedynczą dawkę szczepionki należy podać między 24. a 36. tygodniem ciąży, domięśniowo (co jest zgodne z zapisem w ChPL) [12]. Wcześniej, 21 sierpnia 2023 roku, szczepionkę RSVpreF zatwierdziła amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, *Food and Drug Administration*) do stosowania u kobiet między 32. a 36. tygodniem ciąży [13].

Od 2023 roku Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC, *Centers for Disease Control and Prevention*) rekomenduje kobietom szczepienie przeciw RSV w 32.–36. tygodniu ciąży [14], podobne są też zalecenia Amerykańskiego Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG, *American College of Obstetricians and Gynecologists*) [15].

W wielu krajach zalecenia odnośnie do szczepienia przeciw RSV w ciąży różnią się nieznacznie, głównie w zakresie wieku ciążowego, w którym szczepienie jest zalecane, co zilustrowano w tabeli 1.

Dostępne dane z innych badań wskazują, że potencjalnie większą korzyść, przy niezmienionym ryzyku dla ciężarnej i dziecka, można uzyskać z podania szczepionki między 32. a 36. tygodniem ciąży [14].

Szczepionkę RSVpreF rekomenduje się podać w okresie 32.–36. tygodnia ciąży, jeśli termin porodu przypada na czas tuż przez sezonem lub w trakcie sezonu RSV, czyli od początku września do kwietnia (biorąc pod uwagę sezonowość zakażeń RSV i udokumentowany czas ochrony obejmujący pierwszych 6 mż. dziecka).

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomenduje stosowanie szczepionki przeciw RSV kobietom w 32.–36. tygodniu ciąży. W przypadku występowania ryzyka położniczego (porodu przedwczesnego) możliwe jest podanie szczepionki wcześniej, to jest pomiędzy 24. a 36. tygodniem ciąży, co jest zgodne z ChPL.

Zgodnie z zaleceniami eksperckimi dopuszczalna jest koadministracja szczepionki przeciw RSV ze szczepionką przeciw grypie (inaktywowaną) [22]. Koadministracja oznacza podanie kilku szczepionek jednego dnia (podczas jednej wizyty) w różne, odległe anatomicznie miejsca (najczęściej są to różne kończyny, w przypadku podawania różnych szczepionek w jedną kończynę należy zachować minimalny odstęp pomiędzy miejscami iniekcji, wynoszący 3 cm) [22]. W przypadku koadministracji szczepionki przeciw RSV ze szczepionką przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi (Tdpa) w ChPL zawarty jest zapis o zachowaniu 2-tygodniowego odstępu pomiędzy szczepieniem przeciw RSV i Tdpa ze względu na to, że „odpowiedzi immunologiczne na składnik krztuścowy były mniejsze po jednoczesnym podaniu w porównaniu z oddzielnym podaniem i nie spełniały kryteriów co najmniej równoważności" [23]. Ponieważ znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane, w rekomendacjach zarówno polskich, jak i zagranicznych koadministracja tych szczepionek jest dopuszczalna [14, 22]. W praktyce oznacza to, że szczepionka przeciw RSV oraz szczepionka przeciw krztuścowi (Tdpa), podobnie jak inaktywowana szczepionka przeciw grypie, może być podana tego samego dnia, w odległe anatomicznie miejsca (co może być szczególnie korzystne w przypadku złej sytuacji epidemiologicznej lub krótkiego czasu, który pozostał do terminu porodu).

W maju 2025 roku ukazało się stanowisko WHO dotyczące stosowania szczepionki przeciw RSV u kobiet w ciąży, które przedstawia tabela 2 [24]. W stanowisku tym:

— podkreślono, iż dla jednej pary matka–dziecko zalecana jest jedna forma profilaktyki (szczepienie matki lub podanie dziecku przeciwciała monoklonalnego);
— dopuszczono możliwość rezygnacji z sezonowej podaży szczepionki;

Tabela 2. Stanowisko WHO dotyczące stosowania szczepienia przeciw RSV kobiet w ciąży [24]

1.	Kraje powinny wprowadzić program profilaktyki zakażeń RSV u niemowląt w wieku < 6 miesięcy z użyciem szczepionki RSVpreF, przeznaczonej do podawania ciężarnym, lub nirsewimabu — długodziałający przeciwciała monoklonalnego (mAb), przeznaczonego do podawania niemowlętom.
2.	U tej samej pary matka–dziecko w profilaktyce biernej ciężkich zakażeń RSV zaleca się stosować szczepionkę RSVpreF lub nirsewimab. Nie ma potrzeby stosowania obu tych metod. W przypadku niemowląt, których matki zaszczepiono przeciwko RSV w okresie ciąży, podanie nirsewimabu można rozważyć, jeśli: • szczepienie matki przeprowadzono < 14 dni przed porodem, • niemowlę po ukończeniu 6. miesiąca życia nadal obciążone jest dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia RSV w pierwszym dla niego sezonie infekcyjnym.
3.	W krajach klimatu umiarkowanego, z sezonowością zakażeń RSV, można rozważyć sezonową realizację programu profilaktyki ciężkich zakażeń RSV u niemowląt, która w porównaniu z całoroczną może być bardziej opłacalna w przypadku nirsewimabu, droższego niż szczepionka RSVpreF. W większości krajów tropikalnych lub subtropikalnych, w których RSV krąży w populacji przez znaczną część roku lub w których nie da się określić wyraźnej sezonowości, dla obu metod profilaktyki preferuje się całoroczną realizację programu.
4.	Jeśli w programie podstawową metodą profilaktyki zakażeń RSV jest szczepienie, zaleca się podanie preparatu RSVpreF kobiecie w III trymestrze ciąży (od 28. tygodnia ciąży), optymalnie ≥ 2 tygodnie przed porodem (jest to czas potrzebny na wytworzenie i transport przezłożyskowych swoistych przeciwciał). Zaleca się, aby szczepienie przeciwko RSV wykonać na pierwszej wizycie prenatalnej w III trymestrze ciąży, co zwiększy szansę ochrony niemowląt urodzonych < 32. tygodnia ciąży, które należą do grupy ryzyka ciężkich zakażeń RSV.
5.	W krajach, w których w ramach profilaktyki ciężkich zakażeń RSV u niemowląt oferowane jest wyłącznie szczepienie ciężarnych, można je wykonać w każdej kolejnej ciąży, ponieważ takie postępowanie prawdopodobnie przynosi korzyści i nie wiąże się z ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Aktualnie nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności takiego postępowania.

RSV (*respiratory syncytial virus*) — syncytialny wirus oddechowy, WHO (*World Health Organization*) — Światowa Organizacja Zdrowia

— dopuszczono możliwość podania szczepionki w kolejnej ciąży;
— nie zalecono górnej granicy wieku ciążowego, kiedy można podać szczepionkę (jednak należy podkreślić, że jeśli poród nastąpi < 14 dni od szczepienia, ochrona dziecka nie będzie optymalna i wówczas zaleca się podanie dziecku przeciwciała monoklonalnego).

Skuteczność szczepionki przeciw RSV u kobiet w ciąży

Skuteczność szczepionki RSVpreF podanej w trakcie ciąży oceniono w wieloośrodkowych badaniach z randomizacją z użyciem placebo. W porównaniu z grupą około 3500 ciężarnych, którym podano placebo, w grupie około 3500 ciężarnych zaszczepionych preparatem RSVpreF stwierdzono zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażenia dolnych dróg oddechowych (LRTD, *lower respiratory tract disease*) o ciężkim przebiegu o etiologii RSV u ich dzieci: o 81,8% w pierwszych 3 miesiącach życia i o 69,4% w pierwszych 6 miesiącach życia. W podgrupie ciężarnych zaszczepionych przeciw RSV między 32. a 36. tygodniem ciąży redukcja ryzyka wyniosła odpowiednio 91,1% i 76,5% [25].

W końcowej analizie badania *Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy* (MATISSE) skuteczność szczepionki, zdefiniowana jako ochrona przed LRTD o ciężkim przebiegu wywołaną RSV wymagającą interwencji medycznej u noworodków i niemowląt, wynosiła 82,4% [95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*) = 57,5–93,9] i 70,0% (95% CI = 50,6–82,5) w ciągu odpowiednio 90 i 180 dni od urodzenia. Szczepionka RSVpreF wywołała silne odpowiedzi immunologiczne u kobiet w ciąży i skutkowała bardzo efektywnym transferem przeciwciał matczynych do noworodków, niezależnie od podgrup (według wieku ciążowego w momencie porodu i szczepienia, liczby dni od szczepienia do porodu, kraju, wieku matki) [26]. Warto dodać, iż szczepienie istotnie redukuje ryzyko ciężkiego zakażenia RSV, nie zapobiega jednak wszystkim zakażeniom. W badaniu klinicznym zaobserwowano 50% redukcję częstości wizyt ambulatoryjnych z powodu RSV w pierwszych 6 miesiącach [25], co oznacza, iż łagodniejsze infekcje mogą się zdarzać, choć rzadziej. Szczepienie matki przeciw RSV zapobiega skutecznie ciężkim zakażeniom u dziecka wywołanym przez RSV lub wymagającym hospitalizacji.

Obecnie dostępne są też wyniki badań opisujące rzeczywistą skuteczność szczepienia przeciw RSV kobiet ciężarnych w celu ochrony niemowląt do 6 miesiąca życia.

Przykładem takiego badania jest BERNI, przeprowadzone w Argentynie (kraju o podobnej do polskiej sytuacji: obciążenie RSV jest znaczne, a nirsewimab nie jest dostępny) [27]. Argentyna, z udaną historią programów szczepień matek przeciwko grypie i krztuścowi, była pierwszym państwem, w którym wdrożono ogólnokrajowy program szczepień jako podstawową strategię zapobiegania RSV wśród niemowląt. Program sezonowy rozpoczął się 1 marca 2024 roku, a szczepionka RSVpreF była dostępna bezpłatnie dla wszystkich kobiet w okresie od 32. do 36. tygodnia ciąży. Wyniki pierwszego sezonu badania BERNI z 2024 roku wykazały, że szczepienie matki przeciwko RSV (RSVpreF) w czasie ciąży jest skuteczną strategią zapobiegania LRTD związanej z RSV wymagającej hospitalizacji u niemowląt w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia, co jest zgodne z wynikami badania III fazy MATISSE [25]. Do badania BERNI włączono 505 niemowląt zaszczepionych w ciąży matek. Skuteczność w zapobieganiu zakażeniom z objawami ze strony dolnych dróg oddechowych prowadzącym do hospitalizacji wyniosła 78,6% (95% CI = 62,1–87,9) u niemowląt od urodzenia do 3. miesiąca (≤ 90 dni) życia oraz 71,3% (95% CI = 53,3–82,3) u niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca (≤ 180 dni) życia. Skuteczność rzeczywista (VE, *vaccine effectiveness*) przeciwko RSV związanym z ciężkim przebiegiem infekcji z objawami LRTD, prowadzącym do hospitalizacji, wynosiła 76,9% (95% CI = 45,0–90,3) u niemowląt do 6. miesiąca życia. Skuteczność szczepionki przeciwko zakażeniom RSV związanym ciężką infekcją prowadzącą do hospitalizacji wynosiła 76,9% (95% CI = 45,0–90,3) u niemowląt do 6. miesiąca życia [27].

Podobne wyniki dotyczące VE szczepionki przeciw RSV podawanej kobietom w ciąży w celu zapobiegania zakażeniom RSV u niemowląt uzyskano w badaniu przeprowadzonym w Szkocji i Anglii [28]. Skorygowana skuteczność szczepienia matek szczepionką RSVpreF w zapobieganiu hospitalizacji niemowląt wyniosła 72,4% (95% CI = 7,8–85,4) w przypadku niemowląt, których matki zostały zaszczepione ponad 14 dni przed porodem, oraz 57,7% (95% CI = 28,2–75,1) w przypadku niemowląt, których matki zostały zaszczepione w dowolnym momencie przed porodem [28].

Bezpieczeństwo szczepionki przeciw RSV u kobiet w ciąży

W badaniach, w których oceniano bezpieczeństwo i tolerancję szczepionki, najczęściej zgłaszanymi odczynami były ból w miejscu wkłucia, bóle głowy, mięśni i nudności. Stan przedrzucawkowy odnotowano u 1,8% zaszczepionych kobiet i u 1,4% kobiet, którym podano placebo, a poród przedwczesny — odpowiednio u 5,7% i 4,7% kobiet [23].

Nie wykryto sygnałów dotyczących bezpieczeństwa u niemowląt w wieku do 24 miesięcy. Częstość działań niepożądanych zgłaszanych u niemowląt w ciągu jednego miesiąca po urodzeniu była podobna w grupie otrzymującej szczepionkę RSVpreF (37%) i w grupie otrzymującej placebo (35%) [23].

Dokonano także przeglądu baz danych (PubMed, Embase, Centralnego Rejestru Badań Kontrolowanych Cochrane i ClinicalTrials.gov) w celu wyszukania artykułów opublikowanych do 8 września 2023 roku, dotyczących skuteczności, immunogenności i bezpieczeństwa szczepionek RSVpreF [29]. Do systematycznego przeglądu i metaanalizy włączono w sumie 22 randomizowane badania kontrolowane z udziałem 78 990 uczestników. Wykazano, że prefuzyjna szczepionka RSVpreF była bezpieczna i skuteczna [29].

Również w końcowej analizie danych z badania MATISSE potwierdzono pierwotne wnioski, że szczepienie matki przeciwko RSV ma korzystny profil bezpieczeństwa zarówno u kobiet w ciąży, jak i noworodków oraz niemowląt [30]. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych różnic w zakresie występowania zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu, w tym przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej lub hospitalizacji noworodków. Odsetek przedwczesnych porodów wynosił 5,7% w grupie RSVpreF i 4,7% w grupie placebo [ryzyko względne (RR, *risk ratio*), 1,20; 95% CI = 0,98–1,46]. Większość stanowiły późne wcześniaki (urodzone pomiędzy 34. a 37. tygodniem ciąży; RSVpreF 89,3%, placebo 93%) [29]. W analizie podgrup krajów o niskich dochodach zaobserwowano podwyższone ryzyko przedwczesnego porodu. Znaczenie kliniczne tej nierównowagi nie jest znane. Wyniki dotyczące noworodków i niemowląt, w tym wskaźniki niskiej masy urodzeniowej i hospitalizacji noworodków, były porównywalne między grupami. Większość dzieci objętych szczepieniem urodziła się po ponad 30 dniach od jego podania [30].

W kolejnych badaniach porejestracyjnych potwierdzono bezpieczeństwo szczepionki. Retrospektywne obserwacyjne badanie kohortowe przeprowadzono w dwóch szpitalach w Nowym Jorku wśród pacjentek, które urodziły dziecko w 32. tygodniu ciąży lub później. Jako punkt pierwszorzędowy obserwowano częstość występowania porodu przedwczesnego (PTB, *preterm birth*), drugorzędowe wyniki obejmowały nadciśnieniowe zaburzenia ciążowe (HDP, *hypertensive disorders of pregnancy*), urodzenie martwego dziecka, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu (IUGR, *intrauterine growth restriction*), przyjęcie na oddział intensywnej terapii noworodków (NICU, *neonatal intensive care unit*), niewydolność oddechową noworodków

przy przyjęciu na oddział intensywnej terapii (OIOM), żółtaczkę noworodkową lub hiperbilirubinemię, hipoglikemię noworodków i posocznicę noworodków. Spośród 2973 kobiet w ciąży 1026 (34,5%) otrzymało szczepienie przeciwko RSV (RSVpreF). Wykazano, że nie wiązało się ono ze zwiększonym ryzykiem PTB po uwzględnieniu potencjalnych czynników zakłócających skorygowany iloraz szans (OR, *odds ratio*, 0,87; 95% CI = 0,62–1,20) [31].

W omówionym przeglądzie baz danych uwzględniono także informacje o bezpieczeństwie i tolerancji szczepionki. Stwierdzono, że do częstych miejscowych działań niepożądanych po szczepieniu prefuzyjnym RSVpreF należą: ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz reakcje ogólnoustrojowe, takie jak zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni, bóle stawów, nudności i dreszcze [29].

Podsumowując, profil bezpieczeństwa szczepionki RSVpreF jest korzystny. W badaniach klinicznych nie wykazano zwiększenia ryzyka powikłań ciążowych ani zagrożenia dla noworodka. Wyniki te potwierdzają obserwacje z rzeczywistej praktyki. Najczęstsze działania niepożądane u matki to odczyny miejscowe i przemijające objawy ogólne typowe dla szczepionek inaktywowanych.

Informacje dodatkowe

1. Obecnie nie ma dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa podawania kolejnych dawek szczepionki przeciw RSV w następnych ciążach. Zgodnie z zaleceniami ACIP i ACOG, jeśli kobieta ciężarna w poprzednim sezonie została zaszczepiona przeciw RSV, a w następnym sezonie jest ponownie w ciąży — nie jest rekomendowane powtórne szczepienie przeciw RSV, lecz podanie dziecku przeciwciała monoklonalnego [14, 15]. Stanowisko WHO z maja 2025 roku dopuszcza stosowanie szczepienia przeciw RSV w każdej kolejnej ciąży [24].
2. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, podanie preparatu przeciwko RSV należy odroczyć u osób z ostrą chorobą o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, przebiegającą z gorączką lub bez gorączki. Szczepionka przeciw RSV jest przeciwwskazana i nie powinna być podawana osobom, u których w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, na przykład anafilaksja, na którykolwiek składnik szczepionki [14]. Szczepionki przeciw RSV nie należy podawać w sytuacji rozpoczynającego się porodu [24].
3. Od 1 kwietnia 2025 roku szczepionka RSVpreF w ramach profilaktyki zakażeń RSV u niemowląt poprzez zaszczepienie matki w okresie ciąży jest bezpłatna (refundacja apteczna, na podstawie recepty — lista C).

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Finansowanie ze środków Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Konflikt interesów

AN-O — wykłady i udział w komitetach doradczych dla firm: Pfizer, GSK, MSD, Sanofi. EK — wykłady i udział w spotkaniach ciał doradczych firm: Sanofi, Pfizer, MSD, GSK. AM-M — wykłady i udział w komitetach doradczych firm MSD i Sanofi. PS — wykłady dla firmy Pfizer. MW — wykłady dla firmy Pfizer i Sanofi. JW — wykłady i udział w komitetach doradczych dla firm: Pfizer, GSK, MSD, Sanofi oraz Viatris.

Piśmiennictwo

1. Obando-Pacheco P, Justicia-Grande AJ, Rivero-Calle I, et al. Respiratory Syncytial Virus Seasonality: A Global Overview. J Infect Dis. 2018; 217(9): 1356–1364, doi: 10.1093/infdis/jiy056, indexed in Pubmed: 29390105.
2. Shi T, McAllister DA, O'Brien KL, et al. RSV Global Epidemiology Network. Global, regional and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study. Lancet. 2017; 390(10098): 946–958.
3. Staadegaard L, Caini S, Wangchuk S, et al. The Global Epidemiology of RSV in Community and Hospitalized Care: Findings From 15 Countries. Open Forum Infect Dis. 2021; 8(7): ofab159, doi: 10.1093/ofid/ofab159, indexed in Pubmed: 34337092.
4. Del Riccio M, Spreeuwenberg P, Osei-Yeboah R, et al. RESCEU Investigators. Burden of Respiratory Syncytial Virus in the European Union: estimation of RSV-associated hospitalizations in children under 5 years. J Infect Dis. 2023; 228(11): 1528–1538, doi: 10.1093/infdis/jiad188, indexed in Pubmed: 37246724.
5. Nair H, Nokes DJ, Gessner BD, et al. Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2010; 375(9725): 1545–1555, doi: 10.1016/S0140-6736(10)60206-1, indexed in Pubmed: 20399493.
6. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 15 października 2024 r. oraz w porównywalnym okresie 2023 r. https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2024/INF_24_10A.pdf (17.10.2024).
7. Borszewska-Kornacka MK, Mastalerz-Migas A, Nitsch-Osuch A, et al. Respiratory Syncytial Virus Infections in Polish Pediatric Patients from an Expert Perspective. Vaccines (Basel). 2023; 11(9), doi: 10.3390/vaccines11091482, indexed in Pubmed: 37766158.
8. RSV Immunization Guidance for Infants and Young Children. www.cdc.gov/rsv/hcp/vaccine-clinical-guidance/infants-young-children.html (12.12.2025).
9. Profilaktyka bierna zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) w populacji niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Wakcynologii — aktualizacja na sezon 2025/2026. https://infekcje.mp.pl/choroby/rsv/wytyczne-przegladowe/393337,profilaktyka-bierna-zakazen-rsv-w-populacji-niemowlat (20.11.2025).

10. Jackowska T, Wrotek A, Beń-Skowronek I, et al. Profilaktyka zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) u dzieci. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii (sierpień 2024 r.). Przegląd Pediatryczny. 2024; 53(2): 4–24, doi: 10.26625/10010.
11. Co wiemy o dwóch nowych szczepionkach przeciw RSV? https://szczepienia.pzh.gov.pl/co-wiemy-o-dwoch-nowych-szczepionkach-przeciw-rsv/ (17.05.2025).
12. European Commission. European Health Union: Commission authorises first vaccine to protect infants from respiratory syncytial virus (RSV) infections. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1740.htm (12.10.2024).
13. FDA Approves First Vaccine for Pregnant Individuals to Prevent RSV in Infants. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-respiratory-syncytial-virus-rsv-vaccine (9.10.2024).
14. Fleming-Dutra KE, Jones JM, Roper LE, et al. Use of the Pfizer Respiratory Syncytial Virus Vaccine During Pregnancy for the Prevention of Respiratory Syncytial Virus-Associated Lower Respiratory Tract Disease in Infants: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2023; 72(41): 1115–1122, doi: 10.15585/mmwr.mm7241e1, indexed in Pubmed: 37824423.
15. Maternal Respiratory Syncytial Virus Vaccination. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2023/09/maternal-respiratory-syncytial-virus-vaccination (12.10.2024).
16. Recommandation vaccinale contre les infections à VRS chez les femmes enceintes — note de cadrage. Haute Autorité de santé, 2024. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3460288/fr/recommandation-vaccinale-contre-les-infections-a-vrs-chez-les-femmes-enceintes-note-de-cadrage (20.09.2024).
17. Calendario Nacional de Vacunación. Argentina 2024. www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024-02-calendario-nacional-vacunacion.pdf (21.09.2024).
18. Recommendations for passive immunisation and vaccination against respiratory syncytial in infants, children and older adults. Royal College of Physicians of Ireland, 2023. https://rcpi.access.preservica.com/uncategorized/IO_9275434a-99ff-44e5-b19c-04771ba2b1c0/ (21.09.2024).
19. An Advisory Committee Statement (ACS) National Advisory Committee on Immunization (NACI) Statement on the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) disease in infants. 2024. https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/vaccines-immunization/national-advisory-committee-immunization-statement-prevention-respiratory-syncytial-virus-disease-infants/naci-statement-2024-05-17.pdf (11.12.2025).
20. Respiratory syncytial virus (RSV) immunisation programme for infants and older adults: JCVI full statement, 11 September 2023. https://www.gov.uk/government/publications/rsv-immunisation-programme-jcvi-advice-7-june-2023/respiratory-syncytial-virus-rsv-immunisation-programme-for-infants-and-older-adults-jcvi-full-statement-11-september-2023 (11.12.2025).
21. Australian Government. Department of Health and Aged Care. Australian Immunization Handbook. Respiratory syncytial virus. https://immunisationhandbook.health.gov.au/contents/vaccine-preventable-diseases/respiratory-syncytial-virus-rsv#vaccines-dosage-and-administration (21.12.2025).
22. Zalecenia polskich ekspertów na rok 2024 dotyczące koadministracji szczepionek osobom dorosłym w profilaktyce zakażeń układu oddechowego. https://opzci.pl/wp-content/uploads/2024/08/Rekomendacje-ekspertow-OPZCI_082024_WWW.pdf (12.10.2024).
23. Charakterystyka produktu leczniczego Abrysvo. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230823160227/anx_160227_pl.pdf (23.12.2025).
24. WHO position paper on immunization to protect infants against respiratory syncytial virus disease, May 2025. https://www.who.int/publications/i/item/who-wer-10022-193-218 (23.12.2025).
25. Kampmann B, Madhi SA, Munjal I, et al. MATISSE Study Group. Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants. N Engl J Med. 2023; 388(16): 1451–1464, doi: 10.1056/NEJMoa2216480, indexed in Pubmed: 37018474.
26. Simões E, Pahud B, Madhi S, et al. Efficacy, Safety, and Immunogenicity of the MATISSE (Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy) Maternal Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine Trial. Obstetrics & Gynecology. 2025; 145(2): 157–167, doi: 10.1097/aog.0000000000005816.
27. Pérez Marc G, Vizzotti C, Fell DB, et al. BERNI study working group. Real-world effectiveness of RSVpreF vaccination during pregnancy against RSV-associated lower respiratory tract disease leading to hospitalisation in infants during the 2024 RSV season in Argentina (BERNI study): a multicentre, retrospective, test-negative, case-control study. Lancet Infect Dis. 2025; 25(9): 1044–1054, doi: 10.1016/S1473-3099(25)00156-2, indexed in Pubmed: 40339585.
28. Williams T, Marlow R, Cunningham S, et al. Bivalent prefusion F vaccination in pregnancy and respiratory syncytial virus hospitalisation in infants in the UK: results of a multicentre, test-negative, case-control study. The Lancet Child & Adolescent Health. 2025; 9(9): 655–662, doi: 10.1016/s2352-4642(25)00155-5.
29. Pang Yi, Lu H, Cao D, et al. Efficacy, immunogenicity and safety of respiratory syncytial virus prefusion F vaccine: systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2024; 24(1): 1244, doi: 10.1186/s12889-024-18748-8, indexed in Pubmed: 38711074.
30. Madhi SA, Kampmann B, Simões EAF, et al. Preterm Birth Frequency and Associated Outcomes From the MATISSE (Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy) Maternal Trial of the Bivalent Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine. Obstet Gynecol. 2025; 145(2): 147–156, doi: 10.1097/AOG.0000000000005817, indexed in Pubmed: 39746206.
31. Son M, Riley LE, Staniczenko AP, et al. Nonadjuvanted Bivalent Respiratory Syncytial Virus Vaccination and Perinatal Outcomes. JAMA Netw Open. 2024; 7(7): e2419268, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.19268, indexed in Pubmed: 38976271.